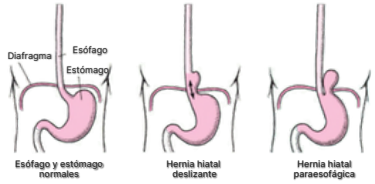
HERNIAS DE HIATO Y REFLUJO GASTROESOFÁGICO

DRA. HEBE ANGELICA AVILÉS

ANATOMÍA Y TIPOS DE HERNIA HIATAL

- Hiato esofágico: formado por los dos pilares del diafragma (derecho e izquierdo), por donde el esófago pasa hacia el abdomen.
- Tipo I (deslizante): la más frecuente (~95%); la unión gastroesofágica migra hacia el tórax.
- Tipo II (paraesofágica pura): la unión GE permanece en su sitio, el fondo gástrico hernia junto a ella.
- Tipos III y IV: mixta (migración de la unión GE + fondo gástrico) y con órganos adicionales (bazo, colon) en el saco herniario.
- Es la causa más frecuente de ERGE y es tratable con cirugía.



CAUSAS DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO

- Defectos del esfínter esofágico inferior: ingesta copiosa, cigarrillo, medicamentos (barbitúricos, benzodiacepinas, antagonistas del calcio).
- Retraso en el vaciamiento gástrico; aumento de la presión intraabdominal (obesidad, embarazo).
- Dieta: comidas grasosas/fritas, alimentos ácidos, chocolate, menta, picantes, cafeína, alcohol, gaseosas.

TRATAMIENTO MÉDICO

- Medidas generales: pérdida de peso, elevar la cabecera de la cama, evitar comidas copiosas antes de acostarse y alimentos desencadenantes.
- Farmacológico: inhibidores de bomba de protones (primera línea), antagonistas H2, procinéticos en casos seleccionados.

CUADRO CLÍNICO

- Síntomas típicos: pirosis (ardor retroesternal) y regurgitación ácida, que empeoran al acostarse o inclinarse.
- Síntomas atípicos: tos crónica, laringitis, asma, dolor torácico no cardíaco, erosión dental.
- Síntomas de alarma (requieren endoscopia): disfagia, pérdida de peso, sangrado, anemia.
- Complicaciones: esofagitis, estenosis péptica, esófago de Barrett (riesgo de adenocarcinoma).

DIAGNÓSTICO

- Endoscopia alta: evalúa esofagitis, hernia hiatal, Barrett; biopsia si hay sospecha de metaplasia.
- pHmetría de 24h: estándar de oro para confirmar y cuantificar el reflujo ácido.
- Manometría esofágica: evalúa la motilidad antes de la cirugía.
- Esofagograma con bario: define el tipo y tamaño de la hernia hiata.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

- Indicaciones: falla al tratamiento médico, deseo de evitar medicación crónica, complicaciones (estenosis, Barrett), hernias paraesofágicas sintomáticas.
- Fundoplicatura de Nissen por laparoscopía: envoltura completa (360°) del fondo gástrico alrededor del esófago distal, descrita por Rudolph Nissen.
- Otras técnicas: fundoplicatura parcial en pacientes con motilidad esofágica alterada.